EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 81283
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-03-25 10:41:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: RICARDO ALFREDO VEGA PRIETO			RUN	: 9.326.246-8
F.Nac	: 04-05-1961	Edad	: 62 AÑOS, 10 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: T. YAVAR SECTOR EL CRUCERO P.5			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 947436640		
Fecha Ingreso	: 2024-03-23	Fecha Egreso	: 2024-03-25 10:41:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-ITU alta febril por Klebsiella oxytoca
-Secuela Grave ACV 2022 / Abandono de tratamiento basal
-DM2 IR con mal control.
-HTA
-HPB
-Dependencia total para ABVD

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

AM: DMT2 IR, ACV secuelado a derecha, HTA, dependencia total para ABVD
Fcos: Losartan 25mg día / Aspirina 100mg día / Carvedilol 6.25 mg día / Sertralina 50mg día / ATV 40 mg día / Tamsulosina 0.4mg día. Insulina NPH 30 - 12uds

Paciente masculino de 62 años con DMT2 IR con mal control por mala adherencia a tratamiento y con dependencia severa para ABVD por ACV secuelado, quien es traído a urgencias por familiar el 21/03/24 por presentar fiebre, asociada a escalofríos y dolor hipogástrico irradiado a región lumbar de 3 días de evolución que se acompaña de orinas de muy mal olor y de aspecto piúrico en domicilio. Al ingreso en exámenes destaca Leucos 19200 / HB 16 / PL 243.000/ PCR 174 / Crea 0.6, hiperglicémico y Orina francamente inflamatoria. Se hospitaliza para manejo.
Evoluciona en sala favorablemente, afebril, hemodinamia estable, bien perfundido. Se rescata UC (+) Klebsiella oxytoca MS, por lo que se mantiene ATB con ceftriaxona, se ajusta esquema de insulina con mejor control metabólico. Exámenes control reporta PSA 0.88, PCR 73.7 Creat 0.5 Leucos 9.800, Rx. de tórax sin imágenes de consolidación o derrame, se toma ecograma reval y vesical (pendiente informe), se realiza educación sobre uso y necesidad de adherencia a insulina y se decide derivar a HODOM para completar tratamiento antibiótico y ajuste de esquema de NPH para control metabólico.

PLAN DE MANEJO:

- Culminar tto antibiótico con HODOM
- Control cardiovascular en APS

INDICACIONES AL ALTA

1. - Alta con HODOM
2. - Cuidados en domicilio

3. - Reposo relativo, movilizar en cama - Prevención de UPP.
4. - Régimen liviano Diabético Hiposódico Asistido
5. - Ceftriaxona 2g ev al día (día 4 de 7)
6. - Insulina NPH subcutánea 26uds predesayuno – 12 uds precena
7. - Mantener tratamiento crónico habitual: Losartan 1/2 vo al dia, Aspirina 100mg vo dia, Carvedilol 6.25 1 vo dia, Sertralina 50 mg vo x día, Tamsulosina 0.4mg vo al día, Atorvastatina 40mg vo al día.
8. - Eco renal y vesical (rescatar informe)
9. - Control en APS en 30 días para control de tratamiento crónico e insulinoterapia.

Neidy Osmary Quijada de Prado
MEDICO TRATANTE
26127834-0

JEFE SERVICIO